

PSICOLOGIA ESPIRITUALIDADE

A Correlação entre a Psicologia e a Espiritualidade na Formação da Personalidade

Manual de estudo · gerado a 10 de junho de 2026

NO PROGRAMA

- Ciência, espiritualidade e psicologia
- Discussão possível entre os conceitos

Unidade 1

OBJETIVOS & AUTO-AVALIAÇÃO

Guia de Estudo — Unidade I: A Correlação entre a Psicologia e a Espiritualidade na Formação da Personalidade

Esta unidade pretende que compreendas o ser humano como um todo integrado, constituído por múltiplas dimensões, e que entendas de que forma a espiritualidade se relaciona com a formação da personalidade.

Objetivos de Aprendizagem

1. Reconhecer o ser humano na sua integralidade e multidimensionalidade

Na prática, significa abandonar a visão cartesiana que separa corpo e mente, e passar a encarar o indivíduo como um ser **biopsicossocial e espiritual**. Segundo Röhr (2013), o ser humano possui múltiplas dimensões interdependentes: uma interferência em qualquer delas afeta necessariamente todas as outras.

Conceito-chave: *Integralidade* — compreender o indivíduo como um todo holístico, sem o reduzir à doença ou ao aspecto biológico.

2. Avaliar as dimensões básicas do ser humano: física, sensorial, emocional, mental e espiritual

Cada dimensão tem funções e limites específicos. As quatro primeiras (física, sensorial, emocional e mental) pertencem ao campo **imanente**; a espiritual pertence ao campo **transcendental**. Conhecer cada uma permite identificar como o bem-estar de uma influencia as demais e como o indivíduo pode alcançar, por expansão, a dimensão espiritual.

Conceito-chave: *Dimensões básicas* (Röhr, 2013) — territórios da natureza humana com sinais e funções específicas, que vão do corpo físico-biológico até os valores éticos e existenciais da espiritualidade.

DEFINIÇÃO

3. Analisar o conceito de espiritualidade e a sua relação com a personalidade

A espiritualidade não equivale a religiosidade: é um campo de valores éticos, questionamentos filosóficos e busca de sentido, confirmados pela intuição. A psicologia tem investigado esta relação através de modelos de personalidade — nomeadamente o modelo P-E-N de Eysenck (três grandes fatores) e o modelo dos Cinco Grandes Fatores — e alguns investigadores, como Piedmont (1999), propõem a transcendência espiritual como um **sexto fator de personalidade**, independente dos cinco existentes.

Conceito-chave: *Transcendência espiritual* — sentido de conectividade com a humanidade e com algo além do self individual, capaz de influenciar positivamente o bem-estar psicológico.

■ Para dominar isto, foca-te em:

- A distinção entre **imanência** (dimensões física, sensorial, emocional e mental) e **transcendência** (dimensão espiritual), conforme Röhr (2013).
- As **cinco dimensões básicas** do ser humano: o que caracteriza cada uma e como se relacionam entre si.
- A diferença conceptual entre **espiritualidade** e **religiosidade**, e por que a primeira não depende necessariamente da segunda.
- A forma como a **personalidade e a espiritualidade se influenciam mutuamente**, com referência aos modelos de traços de personalidade apresentados.
- O contributo de autores como **William James, Jung e Maslow** para uma visão positiva da espiritualidade no campo da psicologia.

RESUMO DA UNIDADE

Resumo da Unidade I: O Ser Humano em Sua Integralidade — Espiritualidade, Multidimensionalidade e Personalidade

Esta unidade enquadra a disciplina "A Correlação entre a Psicologia e a Espiritualidade na Formação da Personalidade" num contexto de superação da dicotomia histórica entre ciência e espiritualidade. A aula inaugural reconhece a tensão entre as correntes racionalistas e mecanicistas — que desvalorizam o que não pode ser medido — e a necessidade de integrar o fenómeno espiritual no estudo holístico do ser humano. A progressão temática avança da definição conceptual (espiritualidade, religiosidade, religião) para a estrutura multidimensional da pessoa humana, culminando na caracterização da espiritualidade como fator de personalidade independente e mensurável.

■ Espiritualidade, Religiosidade e Religião: Distinção Hierárquica

A disciplina parte da urgência de clarificar três conceitos frequentemente confundidos. A **espiritualidade** é a instância mais ampla e profunda — uma relação com o Sagrado e o transcendente que não exige rituais, dogmas nem filiação religiosa. Segundo Belo (2008), nunca existiu um ser humano desprovido de espiritualidade; ela manifesta-se de formas únicas em cada pessoa. Para Saad (2001), a espiritualidade é a "busca inerente da espécie humana em conexão com algo maior que si mesmo, algo que sirva para agregar sentido à sua existência," e é precisamente o que dá sentido à religiosidade.

A **religiosidade** é o nível intermédio: um conjunto de crenças, fundamentos e alguns dogmas e rituais que orientam a relação com o sagrado. É mais específica que a espiritualidade, mas mais ampla que qualquer religião concreta.

A **religião** é a expressão mais específica e concreta — cada religião possui rituais particulares, dogmas (verdades definidas como inquestionáveis, como o dogma católico da virgindade de Maria) e práticas normativas. Uma mesma religiosidade pode gerar religiões diferentes.

A metáfora do filtro de café torna esta hierarquia visual: o funil largo é a espiritualidade; o pó do café é a religiosidade (conjunto de crenças e fundamentos); cada gota que escoar é uma religião específica.

Koenig (2012) define o aspecto espiritual como "uma relação com o Sagrado e o transcendente, que relaciona Deus como o fim, associado a um poder supremo, podendo ou não estar ligado a alguma religião." A distinção entre Deus como fim (a finalidade em si) e Deus como meio (instrumento) é crucial: a espiritualidade contempla o transcendente não como ferramenta, mas como razão de ser.

A psicoterapia holística reconhece que compreender e respeitar a espiritualidade do paciente — sem impor ou julgar escolhas religiosas — contribui para o tratamento integral da saúde mental. O sentido que a religiosidade oferece à vida é, por si só, um recurso terapêutico válido.

Integralidade e Multidimensionalidade: Fundamentos Conceptuais

A **integralidade** é definida pela Constituição Federal de 1988 como "a necessidade de compreender o indivíduo enquanto um todo holístico, um ser biopsicossocial em sua essência." Trata-se de uma assistência ampliada, centrada na pessoa, que recusa reduzir o indivíduo à doença ou ao aspecto biológico. Fontoura e Mayer (2006) descrevem-na como "o próprio caminho que transforma as pessoas e constrói algo melhor para elas," incluindo valorização do cuidado e do acolhimento. O exemplo da cadeira de rodas é ilustrativo: marcar uma consulta no 4.º andar sem rampa destrói a integralidade, independentemente de tudo o resto funcionar bem.

A Lei 8.080/1990 amplia este conceito: integralidade envolve acesso a todos os níveis do sistema de saúde, articulação contínua entre atenção primária, secundária e terciária, e integração entre o individual e o coletivo.

A OMS vem atualizando o modelo biopsicossocial ao acrescentar explicitamente a dimensão espiritual, confirmando que a integralidade abraça também a espiritualidade.

A **multidimensionalidade** é o reconhecimento de que o ser humano existe e atua em várias dimensões em simultâneo. Ferdinand Röhr (2013), filósofo e educador, propõe uma estrutura de **cinco dimensões básicas**:

- **Física/material**: o corpo físico-biológico (células, DNA, fenótipo, genótipo, órgãos); pré-condição para todas as outras.
- **Sensorial**: responsável pelos cinco sentidos; gera ações de atração/repulsa e fuga/permanência.
- **Emocional**: a psique e os estados afetivos; conecta o interior ao exterior.
- **Mental**: pensamento racional, reflexão, memória, imaginação, intuição; exclusiva do ser humano.
- **Espiritual**: valores éticos, questionamentos filosóficos e existenciais confirmados pela intuição; pertence ao campo transcendental.

As quatro primeiras pertencem ao campo **imanente** (aquilo que tem em si próprio o seu princípio e fim, ligado à realidade material); a espiritual pertence ao campo **transcendente** (aquilo que possui um fim externo e superior a si mesmo, ligado à realidade imaterial e metafísica).

Além das dimensões básicas, existem as **dimensões transversais** — que "cortam" as básicas na diagonal e podem atualizar-se, manter-se ou romper-se ao longo da vida: relacional-social, estético-artística, político-económica, comunicativa, místico-mágico-religiosa, sexual-libidinal, ética, de género, lúdica, ecológica, étnica e prático-laboral-profissional. Compreender a profissão como dimensão transversal, por exemplo, abre espaço para recolocações de carreira sem culpa.

As dimensões são **interdependentes e hierárquicas**: a interferência numa afeta necessariamente todas as outras. É por expansão e transcendência das dimensões imanentes que o indivíduo acede à dimensão espiritual.

Ken Wilber (2011) propõe o **Sistema Operacional Integrado (SOI)** para organizar esta multiplicidade de saberes sobre o desenvolvimento humano numa linguagem comum. Cada dimensão encaixa-se nas outras e interage mutuamente. A lógica é circular: para entender o todo é preciso compreender as partes, e para compreender as partes é preciso entender que fazem parte de um todo.

■ As Dimensões Básicas: Caracterização Detalhada

■ Dimensão Física

Inclui toda a corporalidade físico-biológica — genótipo, fenótipo, saúde orgânica. Röhr (2013) define-a como "a pré-condição para manifestação de todas as outras dimensões. É a matéria mais densa, nosso corpo físico-biológico, pela qual circula toda a rede de membros, órgãos e tecidos."

O cuidado com a dimensão física impacta diretamente a autoestima, o autoconceito e a autoimagem. Dormir mal provoca olheiras e expressão abatida; uma postura adequada e energia física elevam a percepção de si. Hábitos concretos de cuidado incluem dieta saudável, atividade física e consultas médicas periódicas.

■ Dimensão Sensorial

Responsável pelos cinco sentidos (tato, visão, audição, olfato, paladar). É importante distinguir **sensação** (estímulo captado pelos órgãos dos sentidos) de **percepção** (resultado da interpretação desse estímulo pelo cérebro, implicando consciência). É possível ter sensação sem percepção consciente — fenómeno designado **adaptação sensorial**.

O organismo habitua um estímulo contínuo e cessa de o perceber conscientemente. Exemplos vívidos: o colar no pescoço ignorado enquanto se pensa noutro assunto; o barulho do frigorífico que só se nota quando para; a ferida no pé que só se sente ao tirar o ténis. A percepção recupera-se quando o estímulo muda, cessa ou é associado a novo estímulo.

A dimensão sensorial não se limita ao contacto físico direto; fornece também informações para dimensões mais subtis, como a emocional. A mudança na expressão facial de alguém, por exemplo, produz informação sensorial que alimenta uma reação emocional.

■ Dimensão Emocional

É a ponte entre o interior e o exterior do indivíduo. Contempla a psique e todos os estados afetivos — medo, insegurança, euforia, apatia, tristeza, melancolia, impaciência, dispersão, solidão, saudade, indecisão, pessimismo — e as suas consequências, incluindo a possibilidade de um estado emocional gerar outro.

O **condicionamento emocional por associação** é um mecanismo central: a criança que vê a figura cuidadora reagir com pânico a um inseto passa a reproduzir esse medo em contextos semelhantes. A dimensão emocional gere a **regulação afetiva** — a capacidade de reconhecer as próprias emoções e as dos outros, para agir de forma conveniente.

Casassus (2009) sublinha que "a origem e o manejo das emoções têm implicações formativas, organizacionais e relacionais que não podem ser sufocadas ou negligenciadas." Cordeiro (2012) adiciona que "a

falta de compreensão de que o bem-estar emocional é uma vivência provoca sofrimento com tendências à possessividade."

■ Dimensão Mental

Exclusiva dos seres humanos. Abrange pensamento racional e lógico, reflexão (incluindo sobre si próprio), memória, recordação, imaginação, fantasia, criação de ideias e intuição. Um golfinho consegue encaixar formas, mas não acorda a questionar se é feliz.

A **metaconsciência** — a capacidade de pensar sobre o próprio pensamento — é o traço distintivo. O ser humano questiona "sou feliz?", "o que é a felicidade?", coisa que nenhum animal faz. A **intuição** é saber algo sem conseguir justificar racionalmente esse saber em última instância. Levou-se o chapéu-de-chuva sem saber porquê, e acabou por chover.

■ Dimensão Espiritual

A mais difícil de identificar das cinco dimensões. Transcende a religiosidade. Enquanto a religiosidade pode incluir a espiritualidade, contém elementos (como a intervenção direta de Deus ou a existência de divindades) que são estranhos ou desnecessários à dimensão espiritual em si.

É o campo dos valores éticos, dos questionamentos filosóficos e existenciais, confirmado pela intuição — não pela lógica. Surge quando as outras dimensões não conseguem dar resposta suficiente às questões da existência. Não traça um caminho evolutivo determinado; contempla a participação criativa de todo o ser no ambiente que habita.

A relação entre as dimensões imanentes e a espiritual é hierárquica: é por expansão e transcendência das primeiras que se acede à espiritual. A dimensão espiritual oferece capacidade para suportar sentimentos como raiva, culpa e ansiedade, e para conferir sentido à existência.

■ Viragem Histórica: Da Patologização à Legitimação da Espiritualidade

Durante séculos, manifestações religiosas — mediunidade, visões, êxtases — foram classificadas como possessão demoníaca ou patologia mental. O DSM-III, documento ainda recente, enquadrava vivências espirituais como "episódio psicótico" e "psicose borderline." Esta patologização estava enraizada numa tradição científica que privilegiava o mensurável, o controlável, o racional.

A viragem do século XX é marcada por autores que invertem essa lógica e colocam a espiritualidade no campo da saúde e do bem-estar.

William James foi o primeiro a defender academicamente que a experiência espiritual tem validade científica. Propôs quatro contributos: (1) interesse legítimo da ciência na experiência psíquica e religiosa; (2) definição de verdadeira ciência e refutação do materialismo redutor; (3) conceito de consciência que transcende o mecanicismo; (4) defesa da validade e da importância da experiência espiritual.

Carl Jung opõe-se diretamente à tradição patologizante: para ele, experiências espirituais são manifestações de uma psique saudável. Defende que "a alma é a própria inteligência, independente de tempo e espaço." As vivências místicas e transpessoais representam, portanto, um grau elevado de desenvolvimento psicológico, não um sintoma.

Abraham Maslow, insatisfeito com a sua pirâmide das necessidades original, identifica a espiritualidade como elemento básico do ser humano — não um luxo ou cúpula, mas uma necessidade fundamental. Rela-

ciona as experiências culminantes (peak experiences) com a expressão máxima da saúde e do bem-estar psicológico.

Hood (1976) e Caird (1987) confirmam empiricamente: pessoas que exercem e verbalizam a sua espiritualidade pontuam mais em escalas de bem-estar psicológico e menos em escalas de psicopatologia. A correlação é positiva e mensurável.

O DSM-IV representa um avanço reconhecido: os fenómenos religiosos e espirituais deixam de ser classificados como psicopatologia e passam a ser incluídos como categoria própria do comportamento humano. Porém, a professora alerta: o caminho até aqui foi longo, e ainda estamos apenas algumas edições do DSM afastados dessa visão patologizante.

■ Espiritualidade como Fator de Personalidade: Modelos Contemporâneos

A investigação contemporânea avança a pergunta: a espiritualidade é um fator de personalidade independente dos modelos já existentes?

■ Piedmont e a Transcendência Espiritual (1999)

Piedmont (1999) responde afirmativamente. Propõe a *escala de transcendência espiritual*, que define a espiritualidade por três pilares:

1. **Sentido de conectividade com toda a raça humana:** percepção de pertença e unidade com a humanidade inteira.
2. **Universalidade:** crença na natureza unitiva de toda a vida — uma interconexão fundamental.
3. **Alegria e contentamento no transcendente:** sentimentos de bem-estar e paz resultantes de encontros pessoais com a realidade transcendente, manifestados em oração, contemplação e outras práticas.

Piedmont argumenta que esta dimensão é **independente dos cinco fatores do Big Five** (extroversão, neuroticismo, abertura à experiência, conscienciosidade, amabilidade) e dos três fatores do modelo P-E-N de Eysenck (Psicoticismo, Extroversão, Neuroticismo). É, portanto, um possível sexto fator de personalidade.

■ McDonald e as Cinco Dimensões de Espiritualidade (2000)

McDonald (2000) vai mais longe. Identifica cinco dimensões significativas da espiritualidade e constrói o *inventário de expressões de espiritualidade*:

1. **Orientação cognitiva:** crenças, atitudes e percepções sobre a natureza e a importância da espiritualidade. É a camada racional, a metacognição espiritual — o que a pessoa *pensa* e *acredita* sobre espiritualidade.
2. **Dimensão experiencial/fenomenológica:** experiências descritas como espirituais, religiosas, místicas, de pico, transcendentais e transpessoais. É a espiritualidade vivida de dentro, o que a pessoa *sente* e *vive*.
3. **Bem-estar existencial:** o sentido e o propósito para a existência, e a percepção de si mesmo como capaz de lidar com as dificuldades e limitações da vida humana. A espiritualidade fornece este chão existencial.
4. **Crenças paranormais:** crença em fenómenos que escapam à explicação científica convencional (pré-cognição, psicocinese, aparições, bilocação). É uma dimensão dentro da espiritualidade, não a totalidade.
5. **Religiosidade:** expressão da espiritualidade por meio de símbolos e significados religiosos — dimensão específica dentro da espiritualidade.

Uma distinção crucial em McDonald: a religiosidade é uma *dimensão dentro* da espiritualidade, não o inverso. Isto inverte a perspectiva tradicional e confirma a hierarquia espiritualidade > religiosidade > religião.

■ Cloninger, Svrakic e Przybeck: Modelo Psicobiológico de Temperamento e Caráter (1993)

Cloninger, Svrakic e Przybeck (1993) propõem uma alternativa ao Big Five: o *modelo psicobiológico de temperamento e caráter*. O modelo separa o que é biologicamente herdado do que é socialmente aprendido.

Temperamento (base hereditária/genética):

- Busca pelo novo
- Evitação de sofrimento
- Dependência de recompensas
- Persistência

Caráter (base social/aprendida):

- **Autodiretividade:** autonomia, capacidade de se governar a si mesmo; a sua ausência associa-se à presença de transtornos mentais.
- **Cooperatividade:** sentimento de fazer parte da humanidade como um todo; empatia e sentido de comunidade.
- **Autotranscendência:** sensação de fazer parte do universo como um todo e a ligação à espiritualidade. É um processo de desenvolvimento com cinco estágios:
 - Esquecimento do self vs. egocentrismo
 - Identificação transpessoal vs. individualismo
 - Aceitação espiritual vs. materialismo racional
 - Iluminação vs. objetividade
 - Idealismo vs. praticidade

Cloninger, Svrakic e Svrakic (1997) desenvolvem o *inventário de temperamento e caráter (ITC)*. Constatam que baixos escores de caráter associam-se a irresponsabilidade e transtornos de personalidade; baixos escores de cooperatividade associam-se a défices de empatia e agressividade; baixos escores de autotranscendência associam-se a comportamentos materialistas.

O modelo de Cloninger justifica-se por defender que o Big Five não captura dimensões fundamentais para a compreensão de transtornos de personalidade, nem define explicitamente a estrutura causal subjacente à variabilidade biológica e social dos traços. Ao incluir a espiritualidade via autotranscendência, reconhece a sua relevância para a saúde mental e a formação da personalidade.

■ Convergências e Implicações

Os três modelos — Piedmont, McDonald e Cloninger — convergem numa ideia central: **a espiritualidade é mensurável, tem estrutura fatorial e correlaciona-se com a personalidade de forma independente das dimensões clássicas.**

Esta convergência tem implicações profundas:

1. **Reabilitação científica:** a espiritualidade deixa de ser um domínio nebuloso ou patológico para ser um aspecto legítimo, estruturado e empiricamente validável da personalidade e da saúde mental.

2. **Integralidade renovada:** a compreensão de que espiritualidade é fator independente reforça a necessidade de integralidade no atendimento clínico e terapêutico — não se pode negligenciar dimensão tão fundamental para o bem-estar.
3. **Desenvolvimento humano:** a autotranscendência de Cloninger sugere que o desenvolvimento psicológico inclui um movimento rumo a perspectivas mais amplas, menos egocêntricas e mais conectadas ao transcendente.
4. **Investigação futura:** estes modelos abrem caminho para estudos sobre como diferentes manifestações de espiritualidade (religiosa, não-religiosa, mística, ética) relacionam-se com traços de personalidade, transtornos mentais e fatores de proteção.

A RETER

Em síntese

Conceitos fundadores:

- Espiritualidade, religiosidade e religião existem numa relação hierárquica: a espiritualidade é a instância mais ampla e universal, a religiosidade é a expressão vivida com alguns dogmas e rituais, e a religião é a manifestação institucional específica.
- A espiritualidade é independente de filiação religiosa formal; é uma relação com o Sagrado e o transcendente que todo o ser humano possui de formas únicas.

Estrutura multidimensional:

- O ser humano é multidimensional: física, sensorial, emocional, mental e espiritual.
- As quatro primeiras dimensões pertencem ao campo imanente; a espiritual pertence ao campo transcendente.
- As dimensões são interdependentes e hierárquicas; a interferência numa afeta todas as outras.
- Além das básicas, existem dimensões transversais (profissão, relações, gênero) que podem transformar-se ao longo da vida.

Integralidade:

- O ser humano deve ser compreendido e cuidado como um todo holístico, biopsicossocial e espiritual.
- Isolar os fenômenos espirituais do estudo e do cuidado é prejudicial e contrário à noção de integralidade.

Viragem histórica:

- A espiritualidade foi historicamente patologizada (DSM-III), mas autores como James, Jung e Maslow inverteram esta lógica.
- Evidência empírica (Hood, Caird) mostra que exercer espiritualidade correlaciona-se com bem-estar psicológico aumentado.

Espiritualidade como fator de personalidade:

- Piedmont, McDonald e Cloninger apresentam modelos empiricamente validados que posicionam a espiritualidade como fator de personalidade independente.
- A espiritualidade é mensurável, estruturada e relevante para a compreensão do desenvolvimento e da saúde mental.
-

A autotranscendência (Cloninger) sugere um caminho de desenvolvimento psicológico rumo a perspectivas menos egocêntricas e mais conectadas ao todo.

AULAS DESTA UNIDADE

1. Ser Humano em Sua Integralidade · 37 flashcards
 2. Dimensões Básicas · 37 flashcards
 3. Dimensões Espirituais da Personalidade · 37 flashcards
-

Unidade 2

OBJETIVOS & AUTO-AVALIAÇÃO

Guia de Estudo — Unidade II: Espiritualidade, Psicologia e Saúde

Esta unidade visa mostrar que espiritualidade, psicologia e saúde formam uma tríade interligada, e que os modelos de personalidade ajudam a compreender como a religiosidade se expressa em cada indivíduo.

Objetivos explicados

1. Reconhecer a conexão existente entre espiritualidade, psicologia e saúde

A separação entre ciência e espiritualidade é relativamente recente. A OMS incluiu a dimensão espiritual no conceito multidimensional de saúde em 1988, definindo espiritualidade como o conjunto de emoções e convicções de natureza não material. Na prática, saber isto significa reconhecer que uma mente saudável não é apenas ausência de doença, mas envolve também sentido e propósito de vida.

Conceito-chave: integração bio-psico-socio-espiritual.

2. Avaliar as interfaces, aproximações e diferenças entre psicologia e religião

A psicologia não julga a opção religiosa do indivíduo; estuda o comportamento religioso como qualquer outro comportamento humano. É necessário distinguir *espiritualidade* (experiência interior, não ligada a nenhuma crença específica) de *religião* (instituição com doutrinas, ritos e normas). Freud, por exemplo, via o sentimento religioso como resposta ao desamparo constitucional, enquanto Durkheim o compreendia pela oposição sagrado/profano.

Conceito-chave: distinção entre espiritualidade e religiosidade.

3. Diferenciar o modelo Três Grandes Fatores (Big Three) ou P-E-N de Hans Eysenck

O modelo P-E-N organiza a personalidade em três dimensões biológicas e hierárquicas, que todos possuem em graus diferentes:

- **P** — Psicoticismo: agressividade, frieza, falta de empatia.
- **E** — Extroversão: sociabilidade, assertividade, busca de sensações (o oposto é introversão).
- **N** — Neuroticismo: instabilidade emocional, ansiedade, baixa tolerância ao stress.

Conceito-chave: traços de personalidade com base genética e biológica.

4. Identificar o modelo dos Cinco Grandes Fatores (Big Five)

O modelo OCEAN é atualmente o mais utilizado nas pesquisas sobre personalidade, por ser abrangente e replicável transculturalmente. Os cinco fatores são:

- **O** — Abertura à experiência (curiosidade, imaginação)
-

- **C** — Conscienciosidade (responsabilidade, organização)
- **E** — Extroversão (sociabilidade, otimismo)
- **A** — Amabilidade (empatia, altruísmo)
- **N** — Neuroticismo (instabilidade emocional)

Cada fator subdivide-se em seis facetas, permitindo uma descrição mais fina da personalidade.

Conceito-chave: acrónimo OCEAN e as 30 facetas associadas.

Para dominar isto, foca-te em:

- A definição de saúde da OMS que inclui a dimensão espiritual e o que a distingue de religião.
- Os quatro domínios da atitude religiosa de Aquino (2005): conhecimento, comportamento, sentimento e corporeidade.
- As três dimensões do modelo P-E-N e os seus indicadores comportamentais.
- Os cinco fatores do modelo Big Five (OCEAN) e o significado prático de cada um.
- A diferença entre *traço* e *tipo* na teoria de Eysenck, e por que ambos os modelos são classificados como teorias fatoriais dos traços.

RESUMO DA UNIDADE

RESUMO DA UNIDADE II

A Correlação entre a Psicologia e a Espiritualidade na Formação da Personalidade

Esta unidade constitui um ponto de encontro entre duas disciplinas frequentemente apresentadas como antagónicas: a psicologia científica e a espiritualidade. Estrutura-se em torno de três eixos principais que demonstram como a compreensão da personalidade humana exige integração da dimensão espiritual e religiosa, bem como análise rigorosa dos traços que caracterizam cada indivíduo. O material articula definições psicológicas do sentimento religioso, modelos fatoriais da personalidade e o reconhecimento de que comportamento religioso é comportamento humano legítimo, merecedor de estudo científico.

DEFINIÇÃO

Definição Psicológica do Sentimento Religioso

O Estatuto da Psicologia face ao Comportamento Religioso

A separação entre ciência e espiritualidade é recente — menos de cem anos — e nunca foi negligenciada pela psicologia (Koenig, 2005). A psicologia estuda o comportamento religioso como parte integral do comportamento humano, sem julgar a opção religiosa do sujeito. O objeto de análise é o comportamento emitido no exercício dessa opção, não a validade da crença em si.

■ Perspectivas sobre o Sagrado

Visão psicanalítica (Freud, 1910): O sentimento religioso tem origem no *desamparo* (*Hilflosigkeit*), condição constitucional do ser humano. Essa falta originária manifesta-se como vazio, ansiedade e ameaça quando o outro não responde às necessidades do sujeito. A crença numa potência superior onipotente e protetora funciona como mecanismo de defesa contra essa angústia. Freud não nega a necessidade do sentimento religioso; o problema surge quando ela não é sublimada, transformando-se em revivência neurótica do arcaico — dependência regressiva da imagem paterna da infância.

Durkheim (1996): O sagrado é o traço essencial dos fenômenos religiosos. Sagrado e profano são dois mundos contrários que servem de norte na vida religiosa; o sagrado é uma energia que age sobre o profano, protegendo contra as interdições.

Martinho Lutero (via Safra, 1998): O sagrado é uma realidade de ordem absolutamente diversa da realidade natural — o numen, o "outro absoluto", experimentado como *mysterium tremendum* (vivência de terror perante o ser sagrado).

Eliade (1999): Hierophany — manifestação do sagrado ao homem. O indivíduo torna-se consciente do sagrado pela experiência de oposição ao profano; o divino é compreendido como imanente.

Teologia bizantina: Deus é transcendente na essência e imanente nas energias: contém o mundo mas não está contido nele. O homem é co-criador com Deus; a relação com o Criador é constitutiva do próprio ser humano.

■ Vinculação ao Sagrado e Inconsistência Religiosa

Safra (1998) define vinculação ao sagrado como a relação que o sujeito estabelece com o transcendente. Essa vinculação não coincide necessariamente com a religião declarada — pode ser inconsciente ou contraditória com os dogmas professados. Exemplo ilustrativo: uma pessoa que se declara católica mas recorre a sessões mediúnicas para contactar um familiar falecido. O psiquismo humano é habitado por "deuses" dos mais diversos tipos, nem sempre em consonância com a fé oficial.

■ Modelo Biopsicossocioespiritual

A OMS (1988) integrou a dimensão espiritual no conceito de saúde, expandindo o modelo biopsicossocial clássico. Segundo Lancetti e Amarante (2006), a mente saudável não é mera ausência de doença, mas "um movimento contínuo do indivíduo na busca do bem-estar, de modos de vida sustentáveis diante das adversidades do cotidiano e que o auxiliem no processo de mudança e na produção de subjectividade."

■ Operacionalização do Sentimento Religioso: Modelo de Aquino

Aquino (2005) propôs um modelo psicométrico da religiosidade baseado nos três componentes clássicos da atitude em psicologia social (afetivo, cognitivo, comportamental), desdobrado em quatro domínios:

1. **Conhecimento religioso** — busca de informação sobre doutrinas, escrituras e participação em eventos de troca.
 2. **Comportamento religioso** — valores e normas que orientam decisões e práticas (vestuário, abstenção de transfusão, participação em celebrações).
 3. **Sentimento religioso** — emoções despertadas por música sacra, entrada no templo, relação com o ser superior.
-

4. **Corporeidade religiosa** — expressão corporal da fé (braços erguidos, ajoelhar, reverências, gestos rituais).

■ Fenómeno Religião: Análise Pluridimensional

Hellern, Notaker e Gaarder (2000) propõem análise do fenómeno religião por quatro ângulos compatíveis com os componentes atitudinais de Aquino:

- **Crença/conceito** (dimensão intelectual, cognitiva)
- **Cerimônia** (regras e rituais fixos, comportamental)
- **Organização** (irmandade entre seguidores, social)
- **Experiência** (emoções vivenciadas nos rituais, afetiva)

■ Trajeto Conceptual

A aula estabelece um trajeto do mais específico para o mais amplo: **religião** 'religiosidade' **espiritualidade**.

■ Teorias Fatoriais da Personalidade: Enquadramento Geral

■ Princípios Fundamentais

As teorias dos traços (ou teorias fatoriais) descrevem a personalidade através de propriedades mensuráveis identificadas por análise fatorial — um método estatístico que agrupa itens de um instrumento com base no comportamento semelhante que apresentam numa amostra. Os aglomerados resultantes chamam-se *fatores*. Cada fator investiga um componente da personalidade; nenhum traço, sozinho, define uma pessoa — é o conjunto que a descreve.

DEFINIÇÃO

Conceitos Centrais

Traço: Predisposição relativamente estável do indivíduo a responder de forma semelhante a diferentes estímulos — forma constante e duradoura de reagir ao ambiente.

Tipo: Grupo de traços correlacionados, nível superior na hierarquia conceptual.

Análise fatorial: Método que identifica quantos fatores (componentes) explicam um construto como a personalidade.

■ Modelo PEN de Hans Eysenck (Big Three)

■ Fundamentos Teóricos

Eysenck (1953a) define personalidade como "organização relativamente estável e duradoura do caráter, temperamento, intelecto e físico do indivíduo, que determina os seus ajustamentos próprios ao ambiente." Eysenck (1959) refina: "integração das características afetivas, volitivas, cognitivas e físicas do indivíduo, que formam uma estrutura capaz de diferenciá-lo das outras pessoas."

Os quatro elementos componentes são "mais ou menos estáveis e duradouros", o que implica que a personalidade não é absolutamente fixa — pode sofrer alteração. Eysenck reconhece o papel da aprendizagem e do ambiente, mas enfatiza o caráter determinante e causal dos fatores biológicos, com evidências de componentes hereditários.

Estrutura Hierárquica

O modelo organiza-se em quatro níveis (do menor para o maior): **resposta específica** 'resposta habitual' 'traço' 'tipo'.

Os Três Fatores Tipológicos (P-E-N)

P — Psicoticismo: Padrão marcado por agressividade, hostilidade, egocentrismo, frieza, impulsividade, falta de empatia, criatividade e antissociabilidade. Não é sinónimo de psicose; altos níveis aumentam a vulnerabilidade a ela (ex.: esquizofrenia). Tem base genética — parentes sanguíneos de psicóticos tendem a apresentar altos níveis.

Subdivide-se em:

- **Impulsividade:** impulsividade estreita (responsividade impensada), assunção de riscos, não-planejamento, vivacidade.
- **Busca por sensações.**

E — Extroversão/Introversão: Indivíduos com altos scores são sociáveis, animados, assertivos, despreocupados, dominantes, cordiais e aventureiros. Eysenck liga a extroversão a baixos níveis de excitação cortical, levando à busca de estimulação externa.

O polo oposto é a introversão: pessoas calmas, que evitam grandes grupos, preferem círculos pequenos e atividades contemplativas. Não confundir com timidez, que é dificuldade em habilidades sociais.

N — Neuroticismo/Estabilidade emocional: Varia do temperamento calmo ao nervoso, influenciado pelo sistema nervoso simpático (resposta luta-ou-fuga). Altos níveis associam-se a depressão, ansiedade, ataques de pânico e baixo limiar de ativação — a pessoa reage intensamente a estímulos pouco expressivos. Também chamado emocionalidade.

O polo oposto é a estabilidade emocional: alto limiar de ativação, bom controle, reação intensa apenas a estressores muito expressivos.

A RETER

Síntese Estrutural

As pessoas não se enquadram num único tipo; apresentam os três, diferindo na intensidade de cada um. O modelo é considerado fatorial porque cada fator agrupa características estatisticamente correlacionadas, identificadas por análise fatorial.

Modelo dos Cinco Grandes Fatores (Big Five)

Contexto Histórico e Epistemológico

O Big Five não tem um único autor. Resulta de décadas de pesquisa acumulada: raízes nos anos 1930, atualização nos anos 1960, popularização nos anos 1990 em paralelo com a expansão da testagem psicológica a nível mundial. É hoje o modelo mais estudado do ponto de vista psicométrico para descrever a personalidade adulta, com as evidências mais robustas dentro da pirâmide científica.

Posicionamento Teórico

O Big Five **não é determinístico**. Reconhece bases biológicas dos traços, mas também a influência das adaptações psicológicas aprendidas através da experiência quotidiana. Os traços atuam como filtros que moldam a forma como cada pessoa interpreta o ambiente e responde aos seus estímulos. McCrae (2006) defende que os traços com base biológica interagem com o ambiente social para orientar o comportamento.

Personalidade (Rebollo e Harris, 2006): "padrões de comportamento e atitudes típicas do indivíduo." Os traços diferem entre pessoas mas são relativamente constantes em cada uma.

Os Cinco Fatores e Facetas

O modelo divide-se em cinco grandes dimensões, cada uma com seis facetas inter-relacionadas (totalizando 30 facetas). As facetas representam a amplitude e o alcance de cada fator, proporcionando informações mais detalhadas do traço temperamental.

EXTROVERSÃO

Nível de sociabilidade, energia e afetuosidade. O polo oposto é a introversão (seriedade, inibição social, preferência por menor estimulação).

Seis facetas:

- **Acolhimento:** ser informal e atrair o social para perto.
- **Gregarismo:** necessidade de companhia e estimulação social constante.
- **Assertividade:** estilo dominante e vigoroso nas interações.
- **Atividade:** agilidade, proatividade, ritmo de vida rápido.
- **Busca de sensações:** preferência por excitação e ambientes estimulantes.
- **Emoções positivas:** alegria, otimismo, riso fácil.

NEUROTICISMO

Instabilidade/estabilidade emocional. Scores altos: ansiedade, pessimismo, alterações bruscas de humor, depressão. Scores baixos: controlo emocional, resposta proporcional, recuperação rápida.

Seis facetas:

- **Ansiedade:** apreensão, nervosismo, tensão.
 - **Raiva/hostilidade:** irritabilidade, pouca cordialidade.
 - **Depressão:** tristeza, culpa, solidão.
 - **Autoconsciência/embaraço:** constrangimento fácil, sensibilidade ao ridículo.
-

- **Impulsividade:** impulsos mais fortes que a vontade.
- **Vulnerabilidade:** susceptibilidade ao stress.

Nota importante: Alterações frequentes de humor não equivalem automaticamente a transtorno bipolar; são tendência de traço.

ABERTURA À EXPERIÊNCIA

Interesse genuíno e intrínseco numa grande variedade de experiências. Quem pontua alto é flexível, criativo, curioso, com interesse cultural e imaginativo. Quem pontua baixo prefere rotina, experiências conhecidas e valores tradicionais.

Seis facetas:

- **Fantasia:** imaginação forte, criatividade.
- **Estética:** amor pela música, poesia, pintura, artes.
- **Sentimentos:** vivência intensa dos estados emocionais, vida emocional profunda.
- **Ações variadas:** preferência por variedade de atividades e novidades.
- **Ideias:** busca por novos conhecimentos, desafios intelectuais.
- **Valores:** valorização da honra e manutenção da tradição.

Distinção importante: Abertura e extroversão são independentes. Uma pessoa pode ser introvertida e ter alta abertura à experiência.

Motivação intrínseca vs. extrínseca: A abertura baseia-se em motivação intrínseca (interesse genuíno, vindo de dentro), não em recompensa externa.

AMABILIDADE

Tendência para comportamentos pró-sociais. Quem pontua alto é caloroso, generoso, leal, dócil e socialmente agradável. Quem pontua baixo é mais centrado em si, desconfiante e com baixa cordialidade.

Seis facetas:

- **Confiança:** crença na honestidade do próximo.
- **Franqueza:** sinceridade e ingenuidade (papel do psicólogo: distinguir se vem de autenticidade ou falta de leitura do contexto).
- **Altruísmo:** generosidade e disposição para ajudar.
- **Complacência:** perdão e inibição da agressão.
- **Modéstia:** humildade e sentimento de igualdade perante os outros.
- **Sensibilidade:** compaixão e empatia.

CONSCIENCIOSIDADE

Grau de autodisciplina, organização e senso prático. Quem pontua alto é responsável, zeloso, honesto, cauteloso, organizado e persistente. Quem pontua baixo é relaxado, distraído, sem ambição e facilmente desencorajado.

Seis facetas:

- **Competência:** sentido de preparo e capacidade para enfrentar dificuldades.
 - **Ordem:** comportamento orientado para manter o ambiente organizado.
-

- **Senso de dever:** ética pessoal e compromisso com obrigações morais.
- **Esforço por realizações:** determinação, ambição, orientação para alcançar objetivos.
- **Autodisciplina:** automotivação que reduz procrastinação.
- **Ponderação:** deliberação antes da ação, cuidado nas decisões.

■ Acrônimo OCEAN

Os cinco fatores são frequentemente representados pelo acrônimo **OCEAN** (em inglês):

- **Openness** (Abertura à Experiência)
- **Conscientiousness** (Conscienciosidade)
- **Extraversion** (Extroversão)
- **Agreeableness** (Amabilidade)
- **Neuroticism** (Neuroticismo)

Replicabilidade e Predominância Científica

García (2006) identifica a replicabilidade como principal razão da predominância do Big Five: os cinco fatores foram encontrados independentemente do país, dos instrumentos de medição utilizados e dos sujeitos avaliados.

■ Instrumentos de Avaliação

- **BFP** (Bateria Fatorial de Personalidade) — versão brasileira.
- **NEO-PI-R** (Inventário de Personalidade NEO Revisado) — instrumento de referência internacional que avalia os cinco fatores e as 30 facetas.

A RETER

Síntese

O comportamento religioso é comportamento humano legítimo. A psicologia estuda a vinculação ao sagrado sem julgar a opção religiosa, reconhecendo que essa vinculação pode ser inconsciente ou contraditória com a religião declarada. O sentimento religioso tem origem psicanalítica no desamparo constitucional (Freud) e funciona como resposta à angústia existencial.

A espiritualidade integra a saúde mental. O modelo biopsicossocioespiritual (OMS, 1988; Lancetti e Amarante, 2006) reconhece que uma mente saudável envolve a busca de bem-estar e de modos de vida sustentáveis, incluindo a dimensão transcendente.

A personalidade é multidimensional e mensurável. Tanto o modelo PEN de Eysenck (três fatores tipológicos) como o Big Five (cinco fatores com 30 facetas) demonstram que a personalidade pode ser descrita através de atributos relativamente estáveis, identificados por análise fatorial. O Big Five, com base em pesquisa acumulada de décadas, oferece o modelo psicométrico mais robusto e replicável para descrever a personalidade adulta.

Os traços têm base biológica mas não são determinísticos. Eysenck enfatiza o caráter determinante dos fatores biológicos; o Big Five reconhece a interação entre bases biológicas e adaptações psicológicas aprendidas. Os traços atuam como filtros interpretativos do ambiente, mas o ambiente também molda a expressão dos traços.

A religiosidade é multidimensional. Aquino (2005) operacionaliza a atitude religiosa em quatro domínios — conhecimento, comportamento, sentimento e corporeidade — mostrando que a experiência religiosa não se reduz a crença intelectual, mas envolve emoção, prática corporal e ação behavioural.

AULAS DESTA UNIDADE

1. Defini o Psicol Gica · 36 flashcards
 2. Modelo Tr S Grandes Fatores · 38 flashcards
 3. Modelo Cinco Grandes Fatores · 56 flashcards
-

Unidade 3

OBJETIVOS & AUTO-AVALIAÇÃO

Guia de Estudo — Unidade III: O Sagrado e o Transcendente

Esta unidade pretende que compreendas como a crença, a transcendência, o sagrado e o divino se articulam na experiência humana, tanto a nível individual como cultural.

Objetivos de Aprendizagem

1. Analisar a temática da transcendência e da religião

Transcendência (do latim *transcendere*, ultrapassar) refere-se ao que está além dos limites humanos e materiais. A religião organiza essa experiência através de símbolos, ritos e crenças partilhados.

Conceito-chave: O ser humano é um "animal simbólico" que cria linguagem, mitos e religião para dar sentido ao que transcende a razão (Nasser, 2006).

2. Identificar as implicações da crença e do compromisso com os aspetos transcendentais da vida

A crença funciona como uma norma que orienta ações e hábitos. Na logoterapia de Frankl, os valores criativos, vivenciais e atitudinais derivam da crença e sustentam o sentido da vida, mesmo nas situações mais extremas.

Conceito-chave: O bem-estar espiritual inclui um componente religioso (relação com o divino) e um componente existencial (sentido da vida), ambos com impacto direto na saúde mental.

3. Diferenciar a relação entre o universo, o divino e o sagrado

O *sagrado* abrange tudo o que está associado a santidade e pode ser representado por objetos, pessoas, tempos ou espaços, dependendo de ritos específicos. O *divino*, por sua vez, não se restringe a lugares nem a rituais: toda a experiência com o divino é sagrada, mas nem toda a experiência sagrada é divina.

Conceito-chave: O numinoso, conceito de Rudolf Otto, designa o elemento irracional e original do sagrado, aquilo que atrai e ao mesmo tempo ultrapassa o ser humano.

4. Avaliar o paralelo entre o divino encontrado na natureza e no cosmos

As tradições orientais (hinduísmo, budismo, confucionismo) tendem a sentir o divino como imanente à natureza; as ocidentais (cristianismo, islamismo, judaísmo) tendem a vê-lo como transcendente ao cosmos, sendo a natureza criação de Deus e responsabilidade do ser humano.

Conceito-chave: Na visão de Rodhen (2008), o "verdadeiro Oriente não é geográfico, mas humano", o que significa que estas duas formas de olhar para o divino são complementares e encontram-se em qualquer parte do mundo.

Para dominar isto, foca-te em:

- A distinção entre **transcendente, sagrado e divino**, e os exemplos concretos de cada um presentes na apostila.
- O conceito de **numinoso** em Rudolf Otto e a diferença entre elementos racionais e irracionais na experiência religiosa.
- A teoria do **sentido da vida em Frankl** e a sua ligação aos valores espirituais.
- O contraste entre as visões **oriental e ocidental** sobre o divino na natureza.
- A ideia de **bem-estar espiritual** como dimensão da saúde, com os seus componentes religioso e existencial.

RESUMO DA UNIDADE

RESUMO DA UNIDADE 3 – A Correlação entre a Psicologia e a Espiritualidade na Formação da Personalidade

Esta unidade aborda o fenómeno religioso como dimensão fundamental do comportamento humano, estabelecendo pontes entre a psicologia, a espiritualidade e a compreensão do transcendente. Parte do pressuposto de que a religiosidade e a espiritualidade não são apenas construtos teológicos, mas factores protectores psicológicos documentáveis que estruturam o significado da vida e orientam a conduta individual e coletiva.

DEFINIÇÃO

I. Conceitos Fundamentais: Transcendência, Crença e Religião

Transcendência

Deriva do latim *transcendere* (ultrapassar). Designa o movimento que vai além dos limites do mundo material, do que pode ser medido, visto ou experimentado cientificamente. Antropologicamente, refere-se a uma forma de relação do ser humano com o que é absoluto, implicando um dinamismo interior (excesso ontológico próprio do espírito) que o leva a sair de si na direção ao horizonte que é fundamento da sua existência.

Objetos Transcendentes

São denominações — palavras, expressões ou objectos físicos — que deixam de ser apenas materiais porque fazem referência ao que é considerado sagrado. Exemplos: "Deus" (cultura ocidental), espíritos, entidades, energias, fé, reencarnação, paraíso, milagres, oração. Não são o sagrado em si, mas remetem a

ele; variam de cultura para cultura. O conceito operacional de "objeto transcendente" funciona como porta de entrada para compreender o que é transcendência.

■ Crença

Uma proposição ou conjunto de proposições que afirma ou nega a relação entre um objeto abstrato e um objeto concreto. Funciona como norma que rege as ações e os hábitos das pessoas. Fundamental para que haja ação; não se concebe a vida humana sem a presença da crença. Quando ligada ao divino, crença e transcendência caminham juntas.

■ Religião

Sistema baseado em crenças que cultuam um ser superior/absoluto responsável pela revelação. Características universais: aceita o sagrado nas experiências vivenciais subjetivas; é representada por um conjunto de símbolos que anunciam o divino, incorporando elementos antropomórficos. Define o significado e propósito do mundo, o lugar do indivíduo nele, as responsabilidades dos indivíduos uns com os outros e a natureza da vida após a morte. É um fenômeno exclusivamente humano: apenas o ser humano reverencia um ser transcendental e produz doutrinas religiosas.

■ Espiritualidade vs. Religiosidade

A metáfora do filtro de café: espiritualidade é a dimensão mais ampla (no alto); religiosidade é o estrato intermédio (o pó de café); cada religião específica é uma gota que passa pelo filtro. A espiritualidade é uma experiência humana do divino e do sagrado, ainda dentro dos limites do humano. A religiosidade é a forma como a pessoa expressa e vive a sua fé, seja em grupo (cultos, preces) ou individualmente.

■ Narrativas Individuais

Relatos pessoais que contêm símbolos, conceitos e palavras que funcionam como estimuladores e organizadores de fenômenos psicológicos. Permitem analisar a conduta religiosa de cada pessoa. A linguagem simbólica — artística, musical, litúrgica, mítica — é o veículo histórico da espiritualidade.

■ II. O Sentido da Vida: Viktor Frankl e a Logoterapia

■ A Experiência e o Pressuposto

Viktor Frankl, psicólogo austríaco e sobrevivente de campos de concentração da Segunda Guerra Mundial, fundou a **Logoterapia** (do grego *logos*, sentido). O pressuposto central é que o ser humano, na sua dimensão espiritual (noética), não é redutível às suas neuroses ou psicoses: existe uma camada que permanece intacta mesmo em circunstâncias extremas, e a partir dela o sentido pode ser construído.

■ Fé Incondicional vs. Fé Condicional

Frankl observou dois tipos de fé nos prisioneiros:

- **Fé incondicional:** fortalece-se diante da catástrofe; a crise aprofunda a ligação com o transcendente.
 - **Fé condicional:** extingue-se quando a situação piora; depende de condições favoráveis.
-

Os prisioneiros com fé incondicional e forte sentido de missão apresentavam melhor autodomínio e sanidade emocional, resistindo melhor ao sofrimento extremo.

■ Sentido da Vida e Valores

O sentido da vida não é algo que se descobre uma única vez; está ligado aos valores e à percepção de missão, de amor e de fé. Não exige religião formal: qualquer pessoa pode encontrar significado independentemente de filiação religiosa. Frankl identificou três razões para viver na sua própria experiência: fé, vocação (missão) e esperança.

Os valores que sustentam o sentido da vida dividem-se em três categorias:

- **Criativos:** o que a pessoa faz, cria, contribui para o mundo.
- **Vivenciais:** o que a pessoa recebe do mundo (beleza, amor, experiência).
- **Atitudinais:** como a pessoa se posiciona e responde diante do sofrimento inevitável.

Os valores orientam a vontade de sentido e a busca de significação; a busca de significação, por sua vez, reforça os valores — formam um ciclo que sustenta a resistência psicológica.

■ Dimensão Noética

Do grego *nous* (mente), refere-se à disciplina que estuda os fenómenos subjetivos da consciência, da mente, do espírito e da vida a partir da perspectiva científica. Define a dimensão espiritual do ser humano. Para Frankl, é a camada que não é afectada por neuroses ou psicoses — a partir dela o sentido pode ser construído mesmo em situações de extrema adversidade.

■ Religiosidade como Factor Protector

A religiosidade e a fé funcionam como factores protectores na saúde mental: produzem autodomínio, regulação emocional e resistência ao sofrimento extremo. Não são apenas conforto teológico, mas estruturas psicológicas documentáveis.

■ III. O Universo, o Divino e o Sagrado

■ Dados Empíricos

Aproximadamente 90% da população mundial considera-se religiosa ou espiritualizada. Desse grupo, cerca de 70% acredita na existência de Deus. Estes dados validam a religiosidade como dimensão significativa do comportamento humano, legítima de análise psicológica.

■ Incógnita Simétrica

Argumento epistemológico central: a ausência de provas da existência de Deus é simétrica à ausência de provas da sua inexistência. Nenhum dos dois lados pode afirmar certeza absoluta. Esta constatação obriga o profissional a uma postura ética de não imposição — não pode afirmar nem negar a existência de Deus ao cliente, respeitando a sua crença.

■ Conceções Culturais: Ocidental vs. Oriental

Contexto Ocidental (Judaico-cristão): A religião é mediadora entre o humano e um ser transcendente exterior ao mundo. Deus é único, criador, transcendente. A ordem e a perfeição das leis do universo têm sido usadas como evidência da existência de um criador (teologia natural).

Contexto Oriental (Budismo, Hinduísmo): Prevalece o **panteísmo**: Deus/sagrado está presente em tudo. Não há necessidade de "ultrapassar" um limite porque o divino já está aqui. Não há separação entre o ser humano e a natureza.

■ Sagrado e Divino: Uma Distinção Assimétrica

- **Sagrado:** tudo o que está relacionado com santidade em qualquer esfera (objeto, pessoa, tempo ou espaço). Requer ritos, lugares ou objectos específicos para ser experienciado.
- **Divino:** dimensão distinta do mundo humano, não sujeita às mesmas leis físicas. As experiências com o divino não dependem de lugar, rito ou objecto específico.

Relação assimétrica: toda experiência com o divino é sagrada; nem toda experiência sagrada é divina.

■ IV. Teorias da Criação do Universo

Menezes (2022) apresenta cinco principais teorias científicas sobre a origem do universo:

1. **Teoria do Big Bang** — George Lemaître (astrônomo belga, baseado em Einstein). O universo originou-se entre 13,7 e 14 mil milhões de anos atrás a partir da explosão de um átomo primordial infinitamente denso e quente. Expandiu, arrefeceu e formou matéria, galáxias, estrelas e planetas.
 2. **Teoria da Gravidade Quântica em Loop** — O espaço-tempo não é contínuo mas granular, composto de "grãos" organizados lado a lado. Diferentemente do Big Bang, não pressupõe uma singularidade inicial, mas um universo anterior em colapso.
 3. **Teoria M** — Fundamenta-se na relatividade geral e na mecânica quântica. Busca unificar cinco versões das supercordas e a supergravidade. Defensores entendem que as diversas teorias coexistentes estão todas essencialmente corretas.
 4. **Seleção Natural Cosmológica** — Criada por Lee Smolin. Transpõe a lógica darwiniana ao cosmos: o universo que conhecemos sobreviveu porque reunia as condições para se manter e gerar vida; outras configurações não sobreviveram.
 5. **Universo Oscilante** — A energia de expansão possui um limite. Após atingir a expansão máxima, o universo retrair-se-á num processo inverso (Big Crunch). O movimento é cíclico, como uma pulsação.
-

■ V. O Divino na Natureza e no Cosmos

■ Relação Histórica Humano-Natureza

Desde a Antiguidade (registada em pinturas rupestres, bem como em civilizações egípcias e mesopotâmias), o ser humano mantém com a natureza uma relação de respeito, admiração e temor. A linguagem moderna, porém, separa artificialmente o homem da natureza ("cuidar da natureza"), quando o homem é parte integrante do sistema natural.

■ Filosofias Orientais

Hinduísmo: Todas as vidas têm a mesma importância e desempenham papéis fixos em conjunto. A perda de qualquer elo afecta o equilíbrio ecológico. Apenas o ser humano possui a dimensão mental reflexiva; os animais cumprem o seu papel sem reflexão. Mas toda vida é sagrada porque parte de um todo interdependente.

Budismo: Defende atitudes simples e não agressivas para com a natureza. Todas as formas de vida estão conectadas entre si e com o cosmos — o universo é uma "cooperativa". A natureza íntima humana partilha elementos comuns com todos os seres vivos (água, pele, sistemas sensoriais). Actitudes agressivas contra a natureza são uma afronta a essa rede de conexão.

Confucionismo: Doutrina filosófica e ética baseada nos ensinamentos de Confúcio, principal doutrina da China durante mais de dois mil anos. Define o ser humano por quatro dimensões constitutivas:

- Eu
- Comunidade
- Natureza
- Céu

A natureza não é exterior ao homem; é uma das suas dimensões fundamentais.

■ Tradições Ocidentais

Cristianismo: A natureza é criação de Deus. O ser humano é seu guardião, com responsabilidade de preservar o bem comum e o património para as gerações futuras.

Islamismo: Alá criou o universo inteiro. A humanidade foi incumbida de guardar a Terra — não como dona, mas como gestora. A manutenção da integridade da Terra é tarefa do ser humano como guardião do planeta.

Judaísmo: O universo foi criado para a humanidade, que é simultaneamente herdeira e responsável pela conservação. A Torá adverte: "Preserve este belo mundo para seus descendentes, porque se deixar de preservar, não haverá chance de restaurar."

■ Criador vs. Gerador (Rodhen, 2008)

Rodhen estabelece uma distinção crucial:

- **Criador:** manipula matéria-prima e produz algo novo.
- **Gerador:** emite energia ou essência para que algo exista.

Para Rodhen, Deus não cria; gera. Toda criatura carrega parte da essência divina porque foi gerada a partir de Deus. Consequência lógica: homem e natureza são, essencialmente, um só.

■ Maya e Brahman

Na tradição oriental:

- **Brahman:** o ser maior, total, real — o objecto transcendente.
- **Maya:** a natureza — a forma como Brahman se materializa. Revela e ao mesmo tempo encobre o divino. Ignorar a natureza/Maya é ignorar Brahman/Deus.

■ Simbologia da Flor de Lótus

Símbolo oriental que representa a relação entre homem e natureza. O fundo lodoso do lago representa o corpo humano; a haste em movimento representa o intelecto. A representação da flor está no coração do homem, indicando que a natureza não é exterior ao ser humano — faz parte da sua essência.

■ Distinção Ocidental: Infantilização da Natureza

A visão ocidental dominante posiciona o ser humano como ser supremo e os outros seres como frágeis, dependentes da sua proteção (discurso do "bichinhos"). Esta perspectiva cria uma distância que as tradições orientais não reconhecem. Segundo Almeida (2013), esta visão é problemática: o homem é o elemento desestabilizador, não o protetor. Não se trata de proteger a natureza "de cima para baixo", mas de reconhecer a integração mútua.

■ Conclusão Lógica: Homem e Natureza como Um

A aula apresenta um argumento silógico:

- Premissa 1: Deus é tudo o que tem alma.
 - Premissa 2: Tudo o que tem alma representa Deus e é parte dele por ter sido gerado.
 - Conclusão: Homem e natureza, tendo ambos alma, representam Deus e fazem parte do mesmo princípio divino. Homem e natureza são um só.
-

■ VI. Autores e Referências-chave

Viktor Frankl (1991, 1994, 1995) — Fundador da logoterapia. Desenvolve a tese de que o sentido da vida é o pilar da saúde psicológica e que a fé (incondicional ou condicional) é um factor protector documentável.

Rudolf Otto (1985) — Autor de *O Sagrado*. Criou o conceito de **numinoso** para designar o aspecto puramente irracional do sagrado — livre de conotações éticas ou morais, é o sentimento de ser criatura diante de algo que transcende mas atrai.

Peter Berger (1985) — Sociólogo. Afirmar que a religião oferece um "dossel sagrado" — cobertura de protecção de imagens simbólicas — diante da precariedade e limitação humana. É a melhor resposta à carência de significados.

Belzen (2009) — A conduta dos indivíduos é sempre preenchida de significados, analisáveis através das narrativas individuais (símbolos, conceitos, palavras como estimuladores de fenómenos psicológicos).

Oliveira (2014) — Define transcendência como uma forma de relação do homem com o absoluto, implicando um dinamismo interior próprio do espírito humano.

Nasser (2006) — Defende que o ser humano é um "animal simbólico", capaz de criar linguagem, mitos, arte e religião por meio de símbolos que fazem parte do mundo humano do sentido.

Rodhen (2008) — Distinção entre criador e gerador. Afirmar que todas as criaturas são representação de Deus. Maya é a materialização de Brahman. A flor de lótus simboliza a relação entre homem e natureza.

Almeida (2013) — Critica a visão ocidental infantilizada da natureza e destaca o homem como elemento desestabilizador, não protetor.

Freitas (2017) — Na cultura ocidental, a denominação mais utilizada do objecto transcendente é "Deus", variando de cultura para cultura.

Menezes (2022) — Descreve as cinco principais teorias da criação do universo.

A RETER

Em síntese

1. **Religiosidade e espiritualidade são dimensões legítimas do comportamento humano**, estudáveis pela psicologia como factores que estruturam significado, orientam condutas e funcionam como protectores psicológicos.
2. **Transcendência designa o movimento para além do limite material**, experienciado através de objectos transcendentos (denominações que remetem ao sagrado). Crença funciona como norma que rege ações; quando ligada ao divino, articula-se com a transcendência.
3. **O sentido da vida é central para a saúde psicológica**: Viktor Frankl demonstra que a fé e a percepção de missão sustentam a resistência ao sofrimento extremo. Valores criativos, vivenciais e atitudinais orientam a vontade de significado num ciclo que reforça a dimensão espiritual.
4. **Sagrado e divino são categorias distintas**: toda experiência divina é sagrada, mas nem toda experiência sagrada é divina. O sagrado requer contextos específicos; o divino transcende qualquer suporte físico.
5. **Contextos culturais diferem profundamente**: o Ocidente (judaico-cristão) concebe um Deus transcendente exterior ao mundo; o Oriente (hinduísmo, budismo) concebe o divino imanente em tudo. O Confucionismo integra a natureza como dimensão constitutiva do ser humano.
6. **A relação entre homem e natureza não é de superioridade, mas de pertença**: tradições orientais (Maya/Brahman, filosofias de Rodhen) e ocidentais (especialmente judaísmo e islamismo) coincidem em reconhecer que o ser humano é guardião ou herdeiro de uma criação que o inclui. A "infantilização ocidental" que vê o homem como protetor superior é problemática.
7. **A dimensão espiritual não é redutível ao material**: a noética (mente, espírito) é exclusiva do ser humano e a partir dela podem ser construídos significado e resistência mesmo em circunstâncias extremas.
8. **A ausência de provas da existência de Deus é simétrica à ausência de provas da sua inexistência**: o psicólogo profissional deve adoptar uma postura ética de não imposição, respeitando a crença do cliente como dimensão legítima da personalidade e do seu comportamento.

AULAS DESTA UNIDADE

1. Crenas Aspectos Transcendentais · 36 flashcards
2. Universo Divino Agrado · 38 flashcards
3. Divino Encontrado Natureza Cosmos · 36 flashcards

Unidade 4

OBJETIVOS & AUTO-AVALIAÇÃO

Guia de Estudo — Unidade IV: A Espiritualidade na Clínica

Esta unidade prepara-te para reconhecer o papel da espiritualidade no contexto clínico e para agir com competência quando esse tema emerge na relação terapêutica.

Objetivos de Aprendizagem

A RETER

1. Identificar a importância da espiritualidade no cuidado e atenção ao paciente

Na prática, isto significa compreender que o paciente não pode ser dividido em dimensões isoladas (biológica, psíquica, social, espiritual): todas são interdependentes. A espiritualidade influencia a adesão ao tratamento, a regulação emocional e a qualidade de vida.

Conceito-chave: modelo biopsicossocial espiritual, que acrescenta a dimensão espiritual às já conhecidas dimensões biológica, psicológica e social.

2. Analisar as possibilidades do terapeuta como um facilitador

Na prática, isto significa perceber que o psicólogo não impõe nem ignora a espiritualidade do paciente; antes, cria condições para que o paciente utilize os seus próprios recursos espirituais. Wulff (1997) descreve quatro posturas possíveis do clínico face à religião: negação literal, afirmação literal, interpretação reduitiva e interpretação restauradora, sendo esta última a mais ética e coerente.

Conceito-chave: o terapeuta como facilitador que reconhece a dimensão espiritual como parte integrante do processo terapêutico, sem invadir nem negligenciar essa esfera.

3. Investigar a influência da fé no processo saúde-doença

Na prática, isto significa avaliar criticamente os efeitos da fé e da religiosidade no tratamento: podem ser protetores (menor prevalência de depressão e ansiedade, maior qualidade de vida) ou prejudiciais (recusa de tratamento, conflitos com a equipa de saúde). A relação não é linear nem sempre positiva.

Conceito-chave: espiritualidade baseada em evidências, isto é, o estudo dos mecanismos pelos quais a fé produz desfechos clínicos concretos, positivos ou negativos.

Para dominar isto, foca-te em:

- Distinguir os três conceitos fundamentais: **religião**, **religiosidade** e **espiritualidade** (definições de Koenig, McCullough e Larson, 2001).
- Conhecer as **quatro categorias de Wulff** (negação literal, afirmação literal, interpretação redutiva, interpretação restauradora) e identificar qual é a mais adequada à prática clínica ética.
- Compreender as **cinco dimensões do modelo biopsicossocial espiritual** (biológica, psicológica, social, espiritual e ambiental) e a sua interdependência.
- Reconhecer os **instrumentos de avaliação espiritual** (questionários FICA e HOPE) como ferramentas práticas para abordar a espiritualidade com o paciente.
- Ter presentes tanto os **efeitos positivos** (menor depressão, ansiedade e suicídio; maior bem-estar) como os **efeitos negativos** (recusa de tratamento, conflitos relacionais) que a espiritualidade pode trazer ao processo saúde-doença.

RESUMO DA UNIDADE

Resumo da Unidade IV: A Espiritualidade na Clínica

Esta unidade desenvolve o papel do psicólogo clínico como facilitador da integração da espiritualidade no processo terapêutico. O trabalho articula a relação histórica entre medicina e espiritualidade, os conceitos de religião, religiosidade e espiritualidade, as posturas éticas do profissional, e a espiritualidade como fator protetivo e facilitador do processo saúde-doença.

A relação histórica entre medicina e espiritualidade

Desde os egípcios (exorcismo com o nome de Hórus) até à Idade Média, espiritualidade e medicina andaram juntas. A Renascença (século XV) criou uma ruptura que durou séculos, interrompendo o diálogo entre os dois campos.

A reaproximação começou com a publicação do artigo *The Faith That Heals* (Sir William Osler, 1910) no *British Medical Journal*, considerado o marco que relançou o debate. Ganhou peso empírico com estudos epidemiológicos publicados na década de 1960, que comprovavam relação positiva entre espiritualidade/religiosidade e saúde. A partir do início do século XX, a perspetiva mudou: até então a religião era vista como possível causadora de neuroses; passou a ser considerada fator positivo para a saúde. No Brasil, os psiquiatras espíritas foram determinantes nesta reaproximação ao defenderem a influência positiva da religião na prevenção de doenças.

DEFINIÇÃO

Definições conceptuais: religião, religiosidade e espiritualidade

As definições de Koenig, McCullough e Larson (2001) estabelecem clareza conceptual e funcionam como referência na clínica:

Religião: Sistema organizado de crenças, práticas, rituais e símbolos designados para facilitar o acesso ao sagrado, ao transcendente — Deus, a força maior, a verdade suprema.

Religiosidade: A crença do indivíduo, o quanto ele segue e pratica uma religião. Pode ser:

- *Organizacional:* participação em comunidade religiosa (igreja, templo, culto).
- *Não organizacional:* rezas, leituras de textos sagrados, programas religiosos, sem pertença institucional.

Espiritualidade: Busca pessoal para compreensão das questões relacionadas à finitude, ao sentido da vida, às relações com o sagrado ou com o transcendente. Pode levar ou não o indivíduo a desenvolver práticas religiosas ou participar de comunidades religiosas.

A relação entre os três conceitos funciona como um funil: espiritualidade é o conceito mais abrangente (contém a busca pessoal de sentido), religiosidade é o nível intermédio (a vivência dessa busca com algum grau de estrutura), e religião é o mais específico (sistema organizado e institucionalizado). A espiritualidade inclui também o ateísmo (crença na não-existência), que deve ser acolhido com o mesmo respeito que qualquer outra crença.

DEFINIÇÃO

A OMS (1948) e o conceito integrado de saúde

A Organização Mundial de Saúde incluiu a dimensão espiritual no conceito multidimensional de saúde, definindo espiritualidade como "o conjunto de todas as emoções, promoções e convicções de natureza não material, com a suposição de que há mais no viver do que pode ser percebido ou plenamente compreendido".

A definição de saúde da OMS é: "Estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não consiste apenas na ausência de doença ou de enfermidade." Desde o início da década de 1980, discute-se a inclusão explícita da dimensão espiritual nesta definição, orientando para o modelo biopsicossocial espiritual.

O psicólogo como facilitador

O psicólogo clínico é um facilitador e mediador do processo terapêutico, não o detentor do saber. Isto significa:

- Reconhecer a dimensão espiritual do paciente como parte integrante do processo terapêutico.
- Criar condições para que o paciente se desenvolva, sem dirigir esse movimento.
- Compreender a vivência espiritual sem a reduzir a explicações exclusivamente psicológicas.
- Aceitar que a espiritualidade é uma dimensão universal do ser humano — não redutível à psicologia, mas relevante para a saúde integral.

A diferença entre compreender e explicar é crucial: a psicologia compreende que o paciente tem uma vivência espiritual; não cabe à psicologia explicar essa vivência pelo viés místico, o que seria antiético. O inverso — reduzir a espiritualidade a puro registo psíquico — seria igualmente redutor.

■ As posturas do psicólogo face à experiência religiosa (Wulff, 1997)

Wulff (1997) classifica quatro categorias de desenvolvimento da experiência religiosa na clínica:

Negação literal: O psicólogo nega por princípio as afirmações religiosas, desconsiderando a fé e as experiências simbólicas do paciente. Nega a transcendência e tende a invalidar a subjetividade do paciente.

Afirmação literal: O psicólogo age de acordo com as suas crenças religiosas pessoais e pretende que o paciente as partilhe. Constitui infração ao artigo 2.º do Código de Ética do Profissional Psicólogo, que veda induzir convicções religiosas.

Interpretação redutiva: O psicólogo elimina a experiência transcendente e reduz o fenómeno religioso a explicações psicológicas ou psicopatológicas. A psicanálise freudiana clássica é o exemplo paradigmático.

Interpretação restauradora: A experiência religiosa é considerada real e específica. O psicólogo está aberto às vivências, símbolos e metáforas do paciente, mantém análise crítica das suas crenças pessoais, e faz perguntas abertas sem impor valores. Implica humildade epistemológica. Esta é a postura mais próxima de uma prática ética e coerente.

O profissional não se posiciona de forma estática numa única categoria: pode mover-se entre elas conforme o contexto clínico, desde que sustentado por discernimento ético. A interpretação restauradora é recomendada como a mais apropriada.

■ Dois limites éticos claros

Aconselhar o paciente a abandonar uma prática religiosa é invasão à integridade do paciente e inibe o processo terapêutico. Encorajar práticas religiosas sem conhecer o contexto é igualmente invasivo. O ponto de equilíbrio é o respeito profundo pelos valores do paciente, com perguntas que exploram sem impor.

■ As cinco dimensões do modelo biopsicossocial espiritual

A aula consolida o modelo que integra cinco dimensões interdependentes:

Biológica: Composição genética, sistemas nervoso, imunológico e endócrino. Base biofísica do organismo.

Psicológica: Sentir, pensar, comportamento, atribuição de sentido, emoções. A forma como o indivíduo percebe e processa o mundo.

Social: Valores culturais aprendidos, trocas entre pares, papéis sociais, leis de conduta que constroem a identidade humana.

Espiritual: Criatividade, fé, imaginação, busca de sentido, capacidade de transcender a si mesmo. Relacionada à dimensão noética (Frankl) — o que distingue o ser humano: a vivência da liberdade e da responsabilidade.

Ambiental: Inter-relação dinâmica e bidirecional entre o ser humano e o ambiente físico; o indivíduo influencia e é influenciado pelo contexto.

Estas dimensões não são compartimentos estanques; funcionam em interação sistémica e dinâmica. Uma alteração numa dimensão repercute nas outras de forma contínua e recíproca.

■ Saúde e doença no modelo holístico

Saúde mental (Lancetti e Amarante, 2006): "Resultado de um movimento contínuo do indivíduo em busca do seu bem-estar, de modos de vida que o sustentem diante das adversidades do cotidiano e que o ajudem num processo de mudança e produção da subjetividade — e não apenas a ausência de doenças."

Doença (Chiattonne, 2011): "Um abalo estrutural na condição de ser, chocando-se ao processo dinâmico de existir, rompendo as relações normais do indivíduo tanto consigo quanto com o mundo que o rodeia."

Saúde e doença têm representações distintas entre indivíduos: uma pessoa com patologia crônica pode sentir-se saudável; uma pessoa sem patologia diagnosticada pode ter o seu bem-estar destruído por um problema existencial. A subjetividade é parte integral do processo saúde-doença.

■ Espiritualidade como fator protetivo e de risco

A espiritualidade **não é automaticamente benéfica**. Funciona tanto como fator protetivo quanto como fator de risco, determinado pelas nuances subjetivas e individualizadas da vivência de cada pessoa.

Como fator protetivo, a espiritualidade/religiosidade:

- Está associada a menores taxas de depressão, stress e suicídio.
- Promove maior qualidade de vida.
- Oferece sentido à vida, reduzindo a desesperança.
- Fornece rede de apoio comunitário e regulação emocional.
- Funciona como recurso de enfrentamento (coping) em situações de adversidade, doença e crise.
- Oferece respostas ao mistério da existência humana.

Como fator de risco, a espiritualidade/religiosidade:

- Pode gerar culpa religiosa ou conflito doutrinário.
- Quando a comunidade religiosa não oferece suporte, o isolamento aumenta.
- Pode induzir a rejeição de tratamento profissional (medicação, terapia).
- Pode provocar sensação de punição divina ou abandono por Deus.
- Pode provocar estresse quando o indivíduo processa as mensagens religiosas de forma traumática.

O que determina qual papel a espiritualidade desempenha é a forma como o indivíduo a experiencia naquele momento específico de vulnerabilidade, não a religião em si.

■ Instrumentos clínicos de avaliação espiritual

Dois questionários estruturados orientam o profissional na abordagem da espiritualidade sem criar mal-entendidos ou forçar um enquadramento religioso:

FICA (Puchalski e Romer, 2000):

- **F** — Fé/crença: Qual é a sua fé religiosa? É importante na sua vida?
 - **I** — Importância/influência: Como a sua fé influencia a forma como cuida de si mesmo?
 - **C** — Comunidade: Faz parte de uma comunidade religiosa ou espiritual?
 - **A** — Ação no tratamento: Como gostaria que considerássemos a sua espiritualidade no seu cuidado?
-

HOPE (Anandarajah e Hight, 2001):

- **H** — fontes de **Hope** (esperança): O que lhe dá esperança?
- **O** — **Religião Organizada**: Tem uma religião ou prática espiritual?
- **P** — **Espiritualidade Pessoal e prática**: Como pratica a sua espiritualidade?
- **E** — **Efeitos no tratamento médico e assuntos terminais**: Como a sua espiritualidade afecta o seu envolvimento no cuidado médico?

Ambos servem para orientar a anamnese espiritual, não para emitir diagnóstico. Permitem identificar fatores de risco (comunidade que não dá suporte, culpa) e fatores de proteção (rede de apoio, sentido de vida), calibrando a abordagem ao contexto clínico e ao vínculo estabelecido.

■ A integração interdisciplinar necessária

Psicologia e religião buscam ambas o sentido da vida e a transformação pessoal (Paiva, 2002). A construção de pontes entre os campos, evitando reducionismos ("só comportamento, só emoção, só crença"), é necessária e urgente.

A dimensão psicológica trabalha a potência do ser no plano humano; a dimensão religiosa trabalha a potência do ser no plano do transcendente/divino. Nenhuma esgota a outra. O ser humano é múltiplo, singular e dotado de ontologia específica (Luczinski, 2005): na relação clínica sempre há algo que escapa ao controlo — e esse algo pode ser precisamente a dimensão espiritual do paciente.

O argumento final é que aceitar o paradigma holístico proposto pela psicologia da saúde é responder aos anseios da ciência e da sociedade. O psicólogo que reconhece a espiritualidade como dimensão real e relevante atua como agente de mudança e promove cuidado integral.

A RETER

Em síntese

- **O psicólogo é facilitador e mediador**, não detentor de verdades absolutas sobre a espiritualidade do paciente.
- **Religião, religiosidade e espiritualidade** são conceitos distintos que funcionam em relação de contenção: a espiritualidade é mais abrangente e não exige religiosidade ou religião.
- **A espiritualidade é dimensão universal** do ser humano e inclui também o ateísmo (como crença), podendo existir independentemente de práticas religiosas organizadas.
- **OMS (1948)** orienta para saúde como estado de bem-estar completo nas cinco dimensões: biológica, psicológica, social, espiritual e ambiental.
- **A postura ética mais apropriada** é a interpretação restauradora (Wulff, 1997): acolher a experiência religiosa como real, com abertura e humildade epistemológica, sem impor convicções.
- **Dois limites éticos**: não aconselhar o abandono de práticas religiosas nem encorajar práticas sem contexto adequado. O Código de Ética proíbe induzir convicção religiosa, não acolher a dimensão espiritual do paciente.
- **Espiritualidade é fator protetivo quando** oferece sentido, rede de apoio, regulação emocional e recursos de enfrentamento; é **fator de risco quando** gera culpa, isola, ou induz rejeição de tratamento.

- **Instrumento FICA e HOPE** estruturam a avaliação espiritual na anamnese, permitindo identificar recursos e riscos sem diagnóstico.
- **Visão holística** não é vaga: é a integração ativa das cinco dimensões para alcançar o bem-estar completo definido pela OMS.
- **Isentar-se das questões espirituais** por medo ou neutralidade aparente é amputar uma dimensão real do paciente e comprometer a qualidade do cuidado.
- **A espiritualidade facilitadora** do processo terapêutico funciona como recurso ativo ao lado do psicólogo na promoção da saúde, prevenção da doença e regulação emocional durante o tratamento.

AULAS DESTA UNIDADE

1. O Terapeuta Como Um Facilitador · 51 flashcards
 2. A Importância da Espiritualidade Clínica · 35 flashcards
 3. Espiritualidade Facilitadora do Processo · 34 flashcards
-